

Gynéco-Obstétrique — Sujet n°1 (IDE L2)

EVALUATION DES ELEVES INFIRMIERS

NIVEAU L2

SUJET NO 1

QUESTIONS A CHOIX DIRECT : Répondre par Vrai (V) ou Faux (F)

Dans le placenta prævia associé à des métrorragies modérées, la césarienne s'impose en urgence (F)

Dans l'HRP, l'étiologie la plus rencontrée est le traumatisme abdominal (F)

Au stade de pré rupture, en cas d'accouchement par voie basse, la révision utérine s'impose (V)

Le partographe est un outil d'aide à la surveillance permettant de détecter précocement les anomalies (F)

La SFA se traduit par un RCIU (F)

La SFC survient toujours au cours du travail d'accouchement (F)

En cas de SFA, si le TV retrouve un col dilaté à 4 cm, la voie basse est possible (F)

Le traitement de la SFC est l'extraction fœtale en urgence (F)

Lors de la TTC si le cordon se coupe, la révision utérine n'est pas indispensable (F)

La révision utérine se fait avec des gants propres (F)

Le cerclage se fait à partir de la 11e SA (V)

Le but de la GATPA est d'accélérer le décollement du placenta afin de réduire les pertes sanguines (V)

Dans la présentation de siège complet on perçoit les fesses et pieds du fœtus (V)

La procidence du cordon est la chute du cordon en avant de la présentation à membranes intactes (F)

Devant un HRP l'on doit prescrire un bilan sanguin avant toute autre action (F)

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE : Choisissez la ou les bonnes réponses

Quelle est l'étiologie la plus rencontrée dans les HPPI ? Cochez la bonne réponse

Rupture utérine

Troubles de la coagulation

Atonie utérine

Thrombus vulvaire

Durant la grossesse, la prise de poids normale est de : Cocher la bonne réponse

3-4 kg par mois

2-3 kg par mois

1-1,5 kg par mois

0-0,5 kg par mois

Parmi les propositions suivantes, deux gestes sont à faire en cas de procidence du cordon battant :

Recouvrir le cordon avec des compresses humides

Installer la patiente en position de Trendelenburg

Hospitaliser la patiente

Renforcer les contractions utérines

Rechercher le battement du cordon par des touchers à répétition

Le placenta praevia dans sa forme typique se traduit par deux signes suivants : Lesquels ?

BDCF présents

Signes de choc non en rapport avec les saignements

Col cerclé

Perception d'un matelas placentaire

Fœtus palpé sous la peau

Quels sont les deux signes en faveur d'un HRP dans sa forme complète ?

Fœtus vivant

Contracture utérine permanente

Col cerclé

Présentation inaccessible au TV

Fœtus palpé sous la peau

Sang rouge minime

Parmi les propositions suivantes laquelle a pour facteur favorisant l'hypertension artérielle :

Le placenta praevia

L'hématome retro placentaire

La rupture utérine

L'hémorragie de Benckiser

Les métrorragies du premier trimestre doivent faire évoquer en premier lieu : Cocher les 2 bonnes réponses

Une grossesse normale

Une GEU

Une grossesse molaire

Une rupture utérine

Placenta praevia

Hématome retro placentaire

Les conséquences de la rupture prématurée des membranes sont : trouvez la réponse inexacte

L'infection de l'œuf.

La procidence du cordon.

L'hydramnios.

L'endométrite du post-partum.

Parmi les propositions suivantes précisez les deux principales permettant de faire le diagnostic de la prééclampsie : cocher les 2 bonnes réponses.

Une infection urinaire.

Une protéinurie supérieure à 0,30 g/24 h.

Une hypertension artérielle supérieure à 14/9.

Des œdèmes des membres inférieurs.

Une prise de poids excessive.

Parmi les propositions suivantes deux sont en faveur d'une GEU. Lesquelles ?

utérus en rapport avec l'âge gestationnel

métrorragies minimales sépia

L'œuf est perçu sous la peau

Masse latéro-utérine

Vomissements incoercibles

Leucorrhées jaunâtres

Parmi les propositions suivantes cocher les deux examens sanguins faisant partie du bilan biologique prénatal:

Groupes sanguin et Rhésus

ECBU

Électrophorèse de l'hémoglobine

Uricémie

Ag HBe

Echographie du premier trimestre

Parmi les propositions suivantes, quelles sont les deux (2) mesures préventives que l'on peut proposer pour prévenir la récurrence de la pré-éclampsie ?

Le régime sans sel.

La prise de 100 mg d'aspirine par jour jusqu'à 36 semaines.

La prise d'un antihypertenseur depuis le début de la grossesse

La prise de la tension artérielle à chaque CPN

L'administration d'acide folique au cours de la grossesse

La réalisation d'un ECBU à chaque CPN

Les fonctions des SONUB sont les suivantes

Administration par voie parentérale d'antibiotiques

Aspiration manuelle intra utérine de restes d'avortement

La transfusion sanguine

Les objectifs de la 1ère CPN sont :

Évaluer les facteurs de risque

Vérifier la bonne évolutivité de la grossesse

Prescrire le traitement préventif et curatif

Confirmer la grossesse

Les examens sanguins faisant partie du bilan biologique de la CPN sont :

Groupes sanguins et Rhésus

Sérologie toxoplasmique

ECBU

Électrophorèse de l'hémoglobine

Uricémie

NFS

Quelles sont les complications immédiates de l'avortement :

Dyspareunies

Tétanos du post abortum

Hémorragies

Perforation utérine

Dans la GEU rompue, quels sont les signes retrouvés ?

Abdomen souple, peu douloureux

Disparition de signes de choc

Cri de l'ombilic

Métrorragies minimales, noirâtres

Dans quel(s) cas l'utérus est-il plus gros que l'âge de la grossesse ?

GEU

Grossesse molaire

Menace d'avortement

Citez deux causes de prématurité

Hydramnios

Grossesse multiple

Anémie

HTA

Parmi les affections suivantes, lesquelles sont responsables de RPM ?

Placenta prævia

Infection vaginale

Macrosomie

VIH